Autos: 0801579-36.2025.8.12.0010
Ação: Procedimento Comum Cível - Padronizado
Autor:Marcio Fior
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul

SENTENÇA

Marcio Fior promove ***"Ação Cominatória com Pedido de Tutela de Urgência"*** em face do **Estado de Mato Grosso do Sul**, ambos qualificados na inicial (p. 1).

Em síntese, a parte autora argumentou que é portador, há longa data, de transtornos psiquiátricos diagnosticados como Transtorno do Espectro Autista infantil (CID F84.0), transtorno depressivo recorrente, em episódio atual grave (CID F33.2), transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade – TDAH (CID F90.0), os quais lhe acarretam importantes limitações cognitivas, emocionais e funcionais. As patologias encontram-se devidamente atestadas por médico psiquiatra da rede pública municipal, ocasionando dificuldades significativas no controle emocional, na concentração, na comunicação e na organização de tarefas, impedindo o autor de exercer atividade laboral, razão pela qual atualmente não aufere qualquer rendimento. Em decorrência das doenças, o autor necessita fazer uso contínuo de medicações específicas, as quais não são fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, gerando custo mensal elevado, incompatível com sua condição financeira. Diante da ausência de renda e da impossibilidade de arcar com as despesas médicas necessárias ao tratamento, o autor encontra-se em situação de vulnerabilidade social, sobrevivendo com o auxílio de seus familiares.

Com base nesses fatos, pediu: a) a concessão de tutela antecipada para determinar que o requerido forneça imediatamente os medicamentos necessários ao tratamento do autor, consistentes em duas caixas de Delefin 100mg (30 unidades), uma caixa de Menelat ODT 30mg orodispersível (30 unidades) e uma caixa de Venvanse 70mg (28 cápsulas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00; b) a procedência do pedido, com a condenação do requerido à obrigação de fazer consistente no fornecimento dos medicamentos indicados, confirmando-se a tutela antecipada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, por preencher os requisitos legais. Deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A petição inicial (p. 1/14) veio acompanhada de procuração, declaração de pobreza e documentos (p. 11/31).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer desfavorável ao pedido (p. 35/50).

Na decisão de p. 51/55, o juízo concedeu assistência judiciária gratuita à autora e deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela.

Em contestação (p. 62/71), o Estado de Mato Grosso do Sul aduziu preliminar de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Discorreu sobre os requisitos específicos para o fornecimento de medicamentos não incorporados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 18/12/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801579-36.2025.8.12.0010 e código su5DZ2am.

ao SUS e a inviabilidade de fornecimento da medicação com base no nome comercial. Diante do exposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. No caso de procedência, requer: a. promovida a intimação da parte autora para emendar a inicial, a fim de incluir a União no polo passivo da demanda, em observância à decisão proferida no RE 1366243/SC (tema 1234). Quanto ao mérito, pede seja(m) julgado(s) improcedente(s) o(s) pedido(s) de: a. fornecimento de medicamento(s) não incorporado(s) ao SUS, em razão do não preenchimento dos requisitos fixados no tema 106 do STJ. No caso de procedência, requer: a. seja direcionado à UNIÃO o cumprimento da obrigação relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, garantindo-se ao Estado o direito de ressarcimento no caso de custeio com recursos próprios. b. seja estipulada a obrigatoriedade da apresentação de receita médica atualizada para retirada dos medicamentos e que seja autorizado o fornecimento com base no princípio ativo, nos termos do art. 3º, §2º da Lei n. 9.787/99. c. no caso de execução forçada do julgado, não haja fixação de multa diária, dando-se preferência ao bloqueio de verbas, nos termos do enunciado 74 da Jornada de Direito da Saúde. d. em caso de bloqueio de valores para aquisição do medicamento, seja observado o PMVG, devendo a nota fiscal ser emitida em no- me e CNPJ do Estado.

Concessão da tutela recursal (p. 72/76).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (p. 85/102).

As partes requereram o julgamento antecipado do mérito (p. 109/111; p. 114).

É o relatório.
Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, conforme prevê o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória.

Nossos Tribunais assim têm se pronunciado a respeito do julgamento antecipado: "*Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder*". (STJ - 4ª Turma - REsp 2.832, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo).

A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: "*O juiz deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art.130). Se o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia*" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475).

Mérito:

Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte requerente aduz que é portadora de Transtorno do Espectro Autista infantil (CID F84.0), transtorno depressivo recorrente, em episódio atual grave (CID F33.2), transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade –

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 18/12/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801579-36.2025.8.12.0010 e código su5DZ2am.

TDAH (CID F90.0) e, devido às suas enfermidades, foram-lhe receitados os fármacos apontados na exordial, os quais não são disponibilizados pelo SUS gratuitamente à população de Fátima do Sul/MS, bem como não possui condições financeiras para custear com os gastos com os medicamentos.

O pedido esboçado pela autora merece acolhimento.

A apreciação do pedido de disponibilização de medicamentos exige cautela, sob pena de imputar consequências irremediáveis ao jurisdicionado e/ou interferir na esfera de competência do Executivo, porquanto, em sendo a saúde um dever, cabe ao Estado implementar políticas sociais e econômicas que visem garantir aos cidadãos, em especial àqueles sem recursos econômicos, o acesso universal e igualitário à assistência médica e farmacêutica.

De início, cumpre anotar que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável ao pleito, relatando, em resumo (p. 35/36, item XI), que:

XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.

Considerando que paciente esta sendo atendido pela rede particular;

Considerando que a Desvenlafaxina, a Mirtazapina e a Lisdexanfetamina **não est**ão padronizados na RENAME 2024;

Considerando que não há tramitação de solicitação de avaliação dos medicamentos solicitados para as patologias apresentadas, em conformidade com a consulta pública a que este Núcleo tem acesso (http://antigo-conitec.saude.gov.br/index.php/tecnologias-em-avaliacao);

Considerando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS n° 07 de 12/04/2022, oferece Risperidona para tratamento da patologia;

Relatório Técnico de Recomendação nº 610 – o dimesilato de lisdexanfetamina foi avaliado para tratamento de indivíduos adultos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade pela CONITEC – conforme Portaria SCTIE/MS nº 20, com a decisão de: não incorporar dimesilato de lisdexanfetamina para TDAH, sendo é indica o tratamento preconizado pelo SUS (não há tratamento farmacológico);

Considerando a Política Nacional de Saúde Mental; Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo; Linha de Cuidado para a Atenção Integral às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas Famílias no Sistema Único de Saúde;

Considerando que a RENAME 2024 tem padronizado no CBAF medicamentos antidepressivos (Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina), anticonvulsivantes (Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Valproato de Sódio), ansiolíticos (Clonazepam solução oral, Diazepam), antipsicóticos (Clorpromazina, Haloperidol), estabilizador do humor (Carbonato de Lítio), sendo que o paciente não informou o uso das estratégias oferecidas pelo SUS

Considerando a ausência dos requisitos específicos exigidos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme estabelecido nos Temas nº 1.234 e nº 6, no qual impõe à parte autora a necessidade de apresentar as fundamentações necessárias;

Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico manifesta-se desfavorável ao pedido de Desvenlafaxina, Mirtazapina e Lisdexanfetamina.

Ressalta-se que, **apesar do parecer desfavorável do NAT, analisando detidamente os documentos que acompanham a inicial, restou comprovado que o pedido comporta deferimento, sendo demonstrada a**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 18/12/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801579-36.2025.8.12.0010 e código su5DZ2am.

imprescindibilidade da medicação requerida e o esgotamento das alternativas fornecidas pela rede pública.

Seguindo as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema repetitivo n. 106 e no TEMA 1234 do STF, verifica-se que os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA (p. 46, item IV).

A parte requerente mencionou que não possui condições financeiras para arcar com o custo do medicamento, o que restou devidamente comprovado através do documento de p. 16.

Quanto à imprescindibilidade dos medicamentos, tem-se que embora o parecer do NAT tenha sido desfavorável, o medico que assiste a parte autora relatou com detalhes a imprescindibilidade do medicamento (p. 19):

MARCIO FIOR
CPF: 813.872.291-68

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de solicitação de medicação, que o paciente **MARCIO FIOR**, 44 anos, vem em tratamento médico psiquiátrico, em regime ambulatorial, devido quadro sintomatológico que preenche critérios para o diagnóstico de **F84.0 + F33.2 + F41.1 + F90.0**, conforme códigos da Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão – CID-10.
No momento está em uso regular de **Desvenlafaxina 200mg/dia + Mirtazapina 30mg/dia e Lisdexanfetamina 70mg/dia.**

Considerado o seu quadro de forma global, é possível inferir que o mesmo necessita de tratamento de forma continua

Sem mais para o momento, desde já, me coloco à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente. Rôneo Reis Machado.

Sendo assim, consignado pelo médico que devem ser utilizados os fármacos prescritos, ora pleiteados, tem-se que tais medicamentos realmente são os mais eficazes ao tratamento da parte autora.

Nesse caminhar, considerando a essencialidade dos medicamentos prescritos para o adequado tratamento da parte autora, entendo que não é prudente privar a parte requerente da medicação receitada pelo profissional de saúde que a acompanha, conhece as peculiaridades de seu quadro clínico e suas condições pessoais, tem primazia na escolha dos medicamentos mais adequados ao tratamento e certamente busca o melhor para contenção da patologia.

Nesse sentido, descabe o argumento de que o médico está restrito a prescrever os medicamentos e tratamentos previstos nos Protocolos Clínicos do SUS ou aqueles constantes na RENAME, tendo em vista que o Código de Ética Médica prevê a liberdade do profissional em indicar o melhor tratamento que aprouver ao paciente, bem como deve aquele usar de todos os meios ao seu alcance para efetivar o direito à saúde, restando demonstrado no caso concreto que o médico bem fundamentou os motivos pelos quais prescreveu medicamentos diferentes dos ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde.

Cumpre consignar que, embora a prescrição médica não goze de presunção absoluta da necessidade do tratamento indicado, tem-se como suficiente para fins de procedência do pedido inaugural, ainda mais quando não demonstrado pela parte contrária a ocorrência de erro ou falha de diagnóstico, de modo a desconstituir o direito autoral.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 18/12/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801579-36.2025.8.12.0010 e código su5DZ2am.

Assim, não tendo o juiz o conhecimento técnico acerca dos tratamentos pleiteados, bem como a evolução do quadro de saúde da paciente, com a devida vênia, deve atender à determinação médica.

Quanto à idoneidade do posicionamento do NAT, é sabido que tal núcleo de apoio foi criado com a finalidade assessorar o Poder Judiciário Estadual, contribuindo com informações técnicas, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, exames, internações e demais tratamentos em face do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo órgão de natureza consultiva.

Portanto, sua função é conferir ao julgador maiores elementos técnicos necessários ao desfecho das lides, sem que o magistrado esteja vinculado aos seus pareceres, os quais são isentos de qualquer parcialidade.

Seguindo tal linha intelectiva, não devem prevalecer as orientações do NAT em situações em que resta demonstrada a imprescindibilidade justificada para a utilização de medicamentos diversos do protocolo clínico estabelecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, tal como ocorreu no caso em tela.

Nesse aspecto, percebe-se do conjunto dos autos que o procedimento objeto do pedido inequivocamente é de natureza essencial ao caso da requerente, o que recomenda o afastamento da conclusão negativa do parecer confeccionado pelo NAT, sendo possível fazê-lo com fulcro no artigo 479 do Código de Processo Civil, que assim dispõe, *in verbis*:

> *"Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".*

No mais, cumpre acrescentar que a falha na distribuição de recursos para os vários ramos da saúde pública não pode nem deve servir de justificativa para a violação do direito constitucional da parte autora, ainda mais no presente caso, em que existe prova material, firmada por médico e corroborada em juízo, noticiando a necessidade dos medicamentos.

Além disso, normas puramente administrativas e questões políticas, como ausência de remédios necessários na lista do RENAME, também não podem servir de óbice à fruição do direito fundamental em questão, repita-se, de estatura constitucional.

E, nesse contexto, uma vez verificado que a negativa de fornecimento em última análise fere o direito à dignidade e à saúde, resguardados a todos os cidadãos pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe-se o acolhimento do pedido.

Neste sentido tem sido o entendimento jurisprudencial:

> *DIREITO À SAÚDE – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – FÁRMACOS HEMIFURATO DE QUETIAPINA E OLANZAPINA –*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 18/12/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801579-36.2025.8.12.0010 e código su5DZ2am.

PADRONIZADOS NO SUS PARA OUTRAS DOENÇAS – USO OFF LABEL PERMITIDO – EXISTÊNCIA DE EFICÁCIA PARA A DOENÇA QUE ACOMETE A PACIENTE – NECESSIDADE COMPROVADA – ***FÁRMACO SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA*** *– RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DA SOLIDARIEDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTATAL – OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 1.234/STF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer destinada à condenação de Ente Público ao fornecimento de medicamentos não padronizado no SUS para a doença que acomete a paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se, no presente recurso: a) a pertinência da condenação do Entes Municipal ao fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS; e, b) a necessidade de direcionamento da obrigação do Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR* ***3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Precedentes do STF.*** *4. No julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, pela 1ª Seção, do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 1.036, do CPC/15, restou assentada tese jurídica estabelecendo três requisitos que devem ser observados, cumulativamente, nas demandas para o fornecimento, pelos Entes Públicos, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, propostas a partir de 04/05/2018. Requisitos Preenchidos. 5. Tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, as novas regras de competência fixadas no julgamento do Tema nº 1234 do STF são aplicáveis exclusivamente às ações propostas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 11/10/2024. Para as ações já em tramitação antes dessa data, como no presente caso, elas permanecerão na esfera em que foram originalmente ajuizadas. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários sucumbenciais.*
*(**TJMS**. Apelação Cível n. 0804888-75.2024.8.12.0018, Paranaíba, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 21/05/2025, p: 23/05/2025)*

Logo, diante de todo esse contexto fático e jurídico, é patente a viabilidade do pedido esboçado na inicial.

Dispositivo:

Posto isso, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **procedente** o pedido, para o fim de **condenar** o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 18/12/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801579-36.2025.8.12.0010 e código su5DZ2am.

requerido **Estado de Mato Grosso do Sul**, **a fornecer em favor da parte requerente, os medicamentos Deller 100mg, Menelat ODT 30mg orodispersível e Venvanse 70mg, conforme prescrição médica (p. 28), no prazo máximo de 15 (quinze) dias** a partir da intimação, **sob pena de sequestro de verba pública suficiente à aquisição dos medicamentos pela rede particular.**

Em observância ao art. 24 da Lei Estadual 3.779 de 2009, fica o requerido isento do pagamento de taxa judiciária.

Diante da sucumbência integral, condeno o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ante a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado pelos profissionais e o tempo na prolação da sentença.

Publique-se a Sentença, registrada automaticamente pelo SAJ..

Intime-se a PGE, via SAJ, dando-se-lhes vista dos autos.

Intime-se a parte autora, por meio da DPE, via SAJ.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo modificação do julgado, arquivem-se os autos, com baixa.

Às providências.

Fátima do Sul, data da assinatura digital.

Vitor Dias Zampieri
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 18/12/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801579-36.2025.8.12.0010 e código su5DZ2am.